AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

UROLOGÍA

Urolitiasis, HPB & Cáncer

16 temas · 1 página cada uno · **7** días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Urolitiasis & Obstrucción Urinaria

★★★ 13.1. Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea 3
★★☆ 13.2. Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía 4
★★☆ 13.3. Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP GES 5
★★★ 13.4. Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica 7

02 Urgencias Urológicas & Escroto Agudo

★★★ 13.5. Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h 8
★★☆ 13.6. Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo 10
★★☆ 13.7. Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes 11
★★★ 13.16. Patología Peneana: Fimosis, Parafimosis, Balanopostitis, Priapismo & Disfunción Eréctil 12

03 Uro-Oncología

★★☆ 13.8. Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason GES 14
★★☆ 13.9. Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia) GES 15
★☆☆ 13.10. Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical GES 16
★★★ 13.11. Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía GES 17
★★☆ 13.12. Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV GES 18

04 Infecciones Urológicas, Quistes & Hematuria

★☆☆ 13.13. Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia 19
★☆☆ 13.14. Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante 20
★★★ 13.15. Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas 21

Números que tienes que saber 22
Fármacos de primera línea 24
GES de la especialidad 24
Plan de repaso de 7 días 26
Índice por prioridad ★ 27

BLOQUE 01 · UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA

13.1 Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

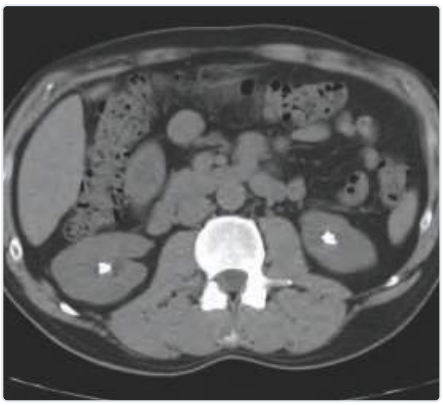
★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

4.03.2.001 Cólico renal — Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

También: Urolitiasis · Pielo TAC · Calciuria · Cólico nefrítico, urolitiasis y complicaciones: obstrucción, sepsis, insuficiencia renal · Radiografía renal y vesical simple · Estudio metabólico de urolitiasis · Instalación pigtail · Uropatía alta · Pielografía de eliminación

LO QUE TE PREGUNTAN

- El dolor cólico renal es provocado por la sobredistensión capsular y piélica mediada por prostaglandinas.
- Los AINEs endovenosos (ketorolaco, ketoprofeno) son la primera línea analgésica obligatoria; los opioides son segunda línea.
- El examen de elección indiscutido para dimensionar el cálculo es el Pielotac (TAC sin contraste).
- Cálculos < **5 mm** expulsan espontáneamente en **80-90%** de los casos; cálculos de **5 a 10 mm** requieren Tamsulosina **0.4 mg**/d.
- **Cálculos > 10 mm requieren resolución quirúrgica activa**: LEOC en polo superior/uréter proximal y Ureteroscopía en uréter distal.



TAC: CÁLCULOS BILATERALES
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 75.21a

ALGORITMO · CÓLICO RENAL: URGENCIA, ANALGESIA Y TAMAÑO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

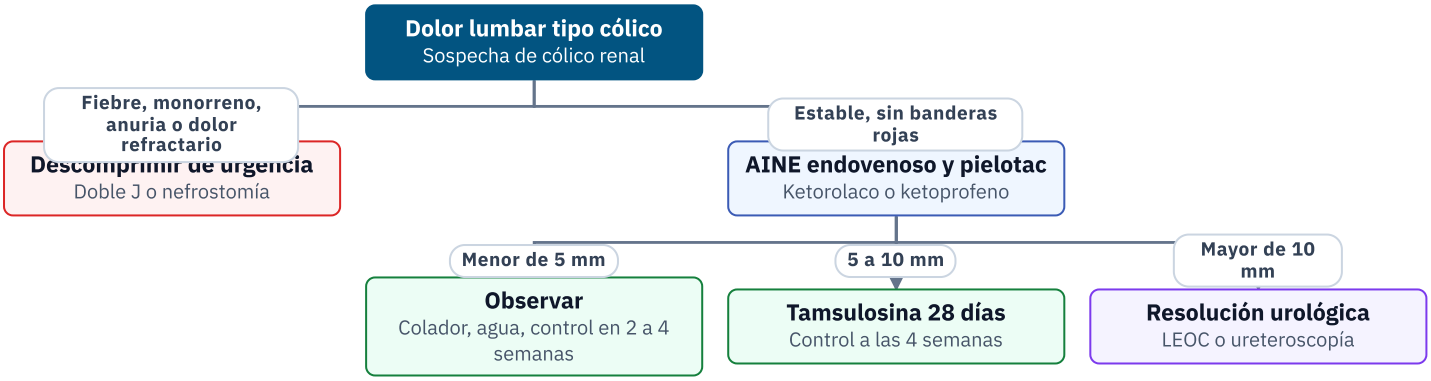


TABLA 13.1 · TIPOS DE CÁLCULOS URINARIOS, FRECUENCIA Y ENFOQUE FISIOPATOLÓGICO

COMPOSICIÓN QUÍMICA	FRECUENCIA	ASPECTO RADIOLÓGICO	PH URINARIO ASOCIADO	TRATAMIENTO ESPECÍFICO
Oxalato de Calcio (Mono/Dihidrato)	75 - 80%	Radiopaco denso	Indiferente (5.5 - 6.8)	Hidratación >3 L/d · Dieta hiposódica e hipoproteica animal · Hidroclorotiazida
Fosfato de Calcio (Brushita/Apatita)	5 - 10%	Radiopaco denso	Alcalino (> 6.5)	Descartar hiperparatiroidismo primario y acidosis tubular renal distal (tipo 1)
Ácido Úrico	5 - 10%	Radiolúcido en Rx (visible en TAC)	Ácido (< 5.5)	Alcalinización urinaria con Citrato de Potasio (meta pH 6.5-7.0) + Alopurinol
Fosfato Amónico Magnésico (Estruvita)	5 - 8%	Radiopaco moderado (Coraliforme)	Muy alcalino (> 7.2)	Asociado a bacterias productoras de ureasa (Proteus) · Nefrolitotomía percutánea + Antibióticos
Cistina	1 - 2%	Débilmente radiopaco (vidrio esmerilado)	Ácido (< 6.0)	Cistinuria congénita · Hidratación masiva (>4 L/d) · Alcalinización + Tiopronina/D-penicilamina

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Cólico renal agudo	AINE endovenoso	Empezar con opioide
Cólico, examen de elección	Pielotac sin contraste	Urotac o urografía
Cálculo de 5 a 10 mm	Tamsulosina	Litotripsia de entrada

REGLA DE ORO **AINE endovenoso primero** — Opioide solo de rescate

PRACTICA **Libro Gordo Urología**, preguntas **4–11** (págs. 8–9) · solucionario págs. 22–23.

Clase 13.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA

13.2 Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

4.03.2.006 Retención urinaria aguda — Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

También: Uropatía obstructiva baja · Instalación y cuidado de sonda Foley · Cistostomía por punción · Uropatía obstructiva · Cistostomía de urgencia · Nefrostomia percutánea · Estenosis uretral · Hidronefrosis · Uretrocistografía · Cistostomía abierta

LO QUE TE PREGUNTAN

- La RAO cursa con dolor hipogástrico agudo y globo vesical palpable y mate a la percusión.
- La instalación de sonda Foley 16-18 Fr es la primera maniobra en ausencia de signos traumáticos.
- Uretrorragia, hematoma perineal en mariposa o fractura pelviana contraindican absolutamente la sonda Foley.
- Ante contraindicación o falla del cateterismo transuretral, se realiza cistostomía suprapúbica por punción.
- La descompresión de la vejiga debe ser completa y continua; el clampeo intermitente está obsoleto.



ECOGRAFÍA: GRAN RESIDUO
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 78.9

ALGORITMO · RETENCIÓN AGUDA DE ORINA: CÓMO DESCOMPRIMIR

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

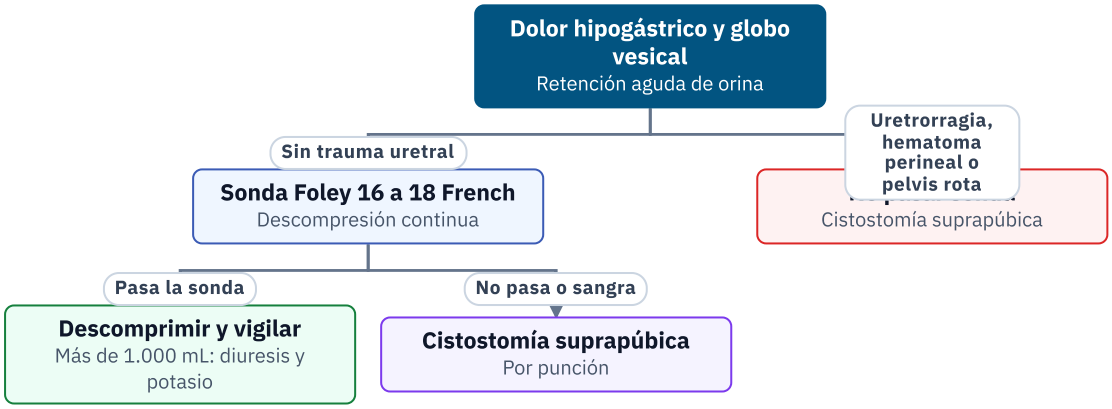


TABLA 13.2 · COMPARACIÓN TÉCNICA: SONDA FOLEY TRANSURETRAL VS CISTOSTOMÍA SUPRAPÚBICA

PARÁMETRO	SONDA FOLEY TRANSURETRAL	CISTOSTOMÍA SUPRAPÚBICA (PUNCIÓN)
Indicación Principal	RAO por HPB, farmacológica o funcional sin trauma	Trauma uretral, estenosis infranqueable, prostatitis bacteriana aguda
Contraindicación Absoluta	Sospecha de lesión uretral (uretrorragia, fractura de pelvis)	Ausencia de globo vesical palpable, cicatrices quirúrgicas bajas múltiples
Calibre habitual	16 a 18 French (adulto)	10 a 14 French (trocar)
Líquido para insuflar balón	Agua bidestilada estéril (10 mL)	Fijación con aletas o balón según modelo
Complicaciones tempranas	Falsa vía uretral, uretrorragia, infección	Punción intestinal (si no hay globo), hematoma de pared abdominal

TRAMPAS EUNACOM

DATO	CONDUCTA	ERROR TÍPICO
Retención con HPB, sin trauma	Sonda Foley	Empezar con alfabloqueante
Uretrorragia o fractura de pelvis	Cistostomía suprapúbica	Pasar la sonda Foley
Sospecha de lesión uretral	Uretrocistografía retrógrada	Cistoscopía o TAC

REGLA DE ORO **Dolor hipogástrico y globo vesical** — Causa frecuente: HPB descompensada

PRACTICA **Libro Gordo Urología**, preguntas **12–17, 20, 57–59, 73** (págs. 9–11, 16, 18) · solucionario págs. 24–25, 30, 33.

Clase 13.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA

13.3 Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

Máxima rentabilidad · fármacos de 1ª línea, efectos adversos de finasteride e indicaciones de cirugía

4.03.1.013 **Hiperplasia prostática benigna** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

También: Uropatía obstructiva baja · Epidemiología del adenoma de próstata · Ecografía vésico-prostática básica · Tacto rectal para reconocimiento básico de crecimiento prostático · Ecotomografía de vejiga y próstata · Uroflujometría

LO QUE TE PREGUNTAN

- La HPB se origina en la zona de transición prostática; el cáncer en la zona periférica.
- El tamaño de la próstata al tacto rectal o ecografía NO se correlaciona linealmente con la intensidad de los síntomas.
- La Tamsulosina (alfa-1 bloqueante) relaja el músculo liso prostático en **48-72 h** sin modificar el volumen ni el APE.
- Finasteride (inhibidor 5-AR) reduce el volumen en **25%** tras **6 meses** y DISMINUYE EL APE AL **50%** (multiplicar x2 para interpretar).
- **Indicaciones absolutas de cirugía**: RAO recurrente, ITU recurrente, litiasis vesical, hematuria prostática recurrente e hidronefrosis.
- La RTUP es de elección para próstatas < **80 cc**; próstatas > **80 cc** requieren adenomectomía abierta o enucleación láser (HoLEP).
- El Síndrome de RTUP (hiponatremia dilucional) ocurría por reabsorción de glicina en RTUP monopolar; hoy se previene con RTUP bipolar con suero fisiológico.



LÓBULOS QUE CIERRAN URETRA
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 75.10

ALGORITMO · HPB: DE LOS SÍNTOMAS AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Urología**, pregunta **18** (pág. 10) · solucionario pág. 24.

Clase 13.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA

13.3 Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 13.3 · COMPARATIVA DE FÁRMACOS EN HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA

FAMILIA FARMACOLÓGICA	FÁRMACOS REPRESENTATIVOS	MECANISMO DE ACCIÓN	INICIO DE EFECTO CLÍNICO	IMPACTO SOBRE APE	EFECTOS ADVERSOS TÍPICOS
Alfa-1 Bloqueantes Selectivos	Tamsulosina (0.4 mg/d), Silodosina	Relajación del músculo liso estromal y cuello vesical	Rápido (48 a 72 horas)	Ninguno (no altera APE)	Eyaculación retrógrada, mareos, congestión nasal, síndrome de iris flácido
Inhibidores de 5-Alfa Reductasa (5-ARI)	Finasteride (5 mg/d), Dutasteride (0.5 mg/d)	Inhibición de isoenzimas de 5-AR; supresión de DHT	Lento (3 a 6 meses)	Reduce APE en un 50% (multiplicar x2)	Disfunción eréctil, disminución de libido, ginecomastia, eyaculación reducida
Terapia Combinada	Tamsulosina + Dutasteride	Sinergia: alivio funcional rápido + reducción anatómica	Rápido y sostenido	Reduce APE en un 50%	Suma de efectos adversos de ambas clases (preferir en próstata >40 cc)
Inhibidores de Fosfodiesterasa-5 (PDE5i)	Tadalafilo (5 mg/d continuo)	Aumento de GMPc, relajación del músculo detrusor y próstata	1 a 2 semanas	Ninguno	Cefalea, rubor facial, dispepsia (indicado si coexiste disfunción eréctil)

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Síntomas moderados, IPSS 8 a 19	Tamsulosina	Partir con finasteride
Finasteride por más de 6 meses	APE medido por 2	Leer el APE tal cual
Próstata de más de 40 cc	Agregar inhibidor 5-ARI	Operar de entrada

REGLA DE ORO **Zona de transición; tacto fibroelástico** — Nódulo duro: sospechar cáncer

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La HPB es el tumor benigno más frecuente en hombres mayores de 50 años. Su origen celular se sitúa en la zona de transición que rodea la uretra proximal, lo que explica por qué el tamaño prostático absoluto no se correlaciona linealmente con la severidad del cuadro clínico: próstatas pequeñas pero con crecimiento endovesical (lóbulo medio) pueden provocar gran obstrucción urinaria. Los alfa-1 bloqueantes actúan relajando el tono muscular del cuello vesical en 48 horas sin reducir el volumen prostático, mientras que los inhibidores de la 5-alfa reductasa reducen el volumen en un 20-30% tras 6 meses y reducen el APE sérico al 50%.

TABLA 13.3.B · INDICACIONES Y SELECCIÓN DE TÉCNICA QUIRÚRGICA EN HPB

MODALIDAD QUIRÚRGICA	CRITERIO DE VOLUMEN PROSTÁTICO	VENTAJAS PRINCIPALES	COMPLICACIONES / RIESGOS ESPECÍFICOS
RTUP Monopolar / Bipolar	Próstata < 80 cc (estándar de oro)	Endoscópica sin herida abdominal · Recuperación rápida (sonda 1-2 días)	Eyaculación retrógrada (75%), sangrado, Síndrome de RTUP (solo monopolar)
Adenomectomía Abierta (Millin)	Próstata > 80 cc	Extracción completa y rápida del adenoma voluminoso en una sola pieza	Mayor sangrado intraoperatorio, herida dolorosa, estadía prolongada (sonda 5-7 días)
Enucleación con Láser (HoLEP)	Cualquier tamaño (incluso > 100 cc)	Excelente hemostasia, aplicable en anticoagulados, baja estadía	Requiere cirujano con curva de aprendizaje prolongada e instrumental costoso
Vaporización con Láser Verde	Próstatas pequeñas a medianas (< 60 cc)	Procedimiento casi ambulatorio, mínimo sangrado	No entrega tejido para biopsia anatomopatológica

PRACTICA **Libro Gordo Urología**, pregunta **18** (pág. 10) · solucionario pág. 24.

Clase 13.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA

13.4 Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica

★★★ PRIORIDAD ALTA
10 preguntas reales 2013–2025

4.03.1.014
1.07.1.012
Incontinencia urinaria

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Urodinamia

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Incontinencia de Esfuerzo ocurre con maniobras de Valsalva sincrónicas sin deseo miccional previo.
- La primera línea de manejo en IUE son los ejercicios de Kegel; la segunda línea es la cirugía con cintas suburetrales (TOT/TVT).
- La Incontinencia de Urgencia se asocia a vejiga hiperactiva y se trata con antimuscarínicos (Oxibutinina) o Mirabegrón.
- Mirabegrón (agonista beta-3) es de elección en ancianos para evitar los efectos adversos cognitivos y anticolinérgicos.
- La Incontinencia por Rebalse cursa con residuo postmiccional elevado (> **200 mL**) y goteo constante.

ALGORITMO · INCONTINENCIA URINARIA DEL ADULTO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

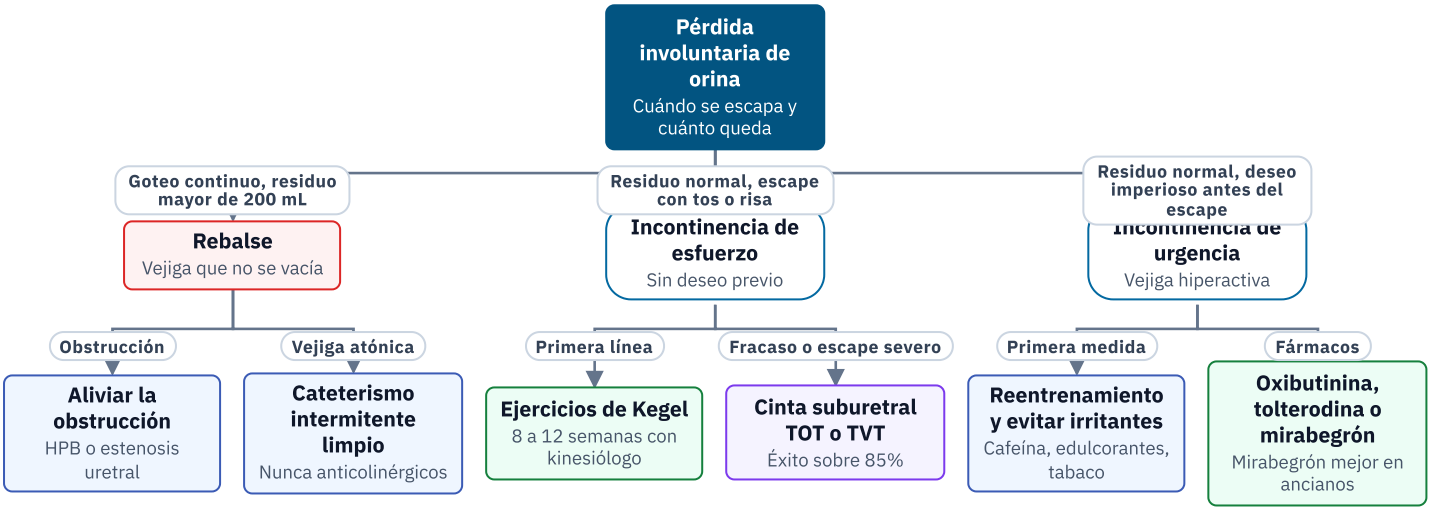


TABLA 13.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS TIPOS PRINCIPALES DE INCONTINENCIA URINARIA

CARACTERÍSTICA	INCONTINENCIA DE ESFUERZO (IUE)	INCONTINENCIA DE URGENCIA (IUU)	INCONTINENCIA POR REBALSE
Mecanismo Primario	Debilidad piso pélvico / Hipermovilidad uretral	Hiperactividad motora del músculo detrusor	Sobredistensión vesical / Falla de contractilidad
Síntoma Rector	Pérdida con tos, risa, estornudo o ejercicio	Escape precedido de deseo imperioso e inaguantable	Goteo continuo constante sin fuerza miccional
Volumen de Pérdida	Pequeño a moderado (en chorritos al pujar)	Moderado a abundante (vaciamiento vesical completo)	Pequeño pero continuo (goteo incesante)
Residuo Postmiccional	Normal (< 50 mL)	Normal (< 50 mL)	Marcaramente elevado (> 200 - 400 mL)
Tratamiento de 1ª Línea	Ejercicios de Kegel · Cirugía con mallas (TOT/TVT)	Oxibutinina / Mirabegrón · Reentrenamiento	Aliviar obstrucción · Cateterismo intermitente limpio
Error que Anula Conducta	Tratar con anticolinérgicos (ineficaces)	Indicar cirugía de mallas suburetrales	Dar anticolinérgicos (provoca RAO severa)

TRAMPAS EUNACOM

DATO	CONDUCTA	ERROR TÍPICO
Escape al toser, sin deseo	Kegel, luego TOT o TVT	Anticolinérgicos
Deseo imperioso y escape	Oxibutinina o mirabegrón	Cirugía con malla
Goteo continuo, residuo > 200 mL	Aliviar la obstrucción o sondear	Dar anticolinérgicos

REGLA DE ORO **Esfuerzo: Kegel, luego cinta** — TOT o TVT si fracasan

PRACTICA **Libro Gordo Urología**, preguntas **22–25** (pág. 11) · solucionario págs. 25–26.

Clase 13.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · URGENCIAS UROLÓGICAS & ESCROTO AGUDO

13.5 Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h

★★★ PRIORIDAD ALTA
6 preguntas reales 2013–2025

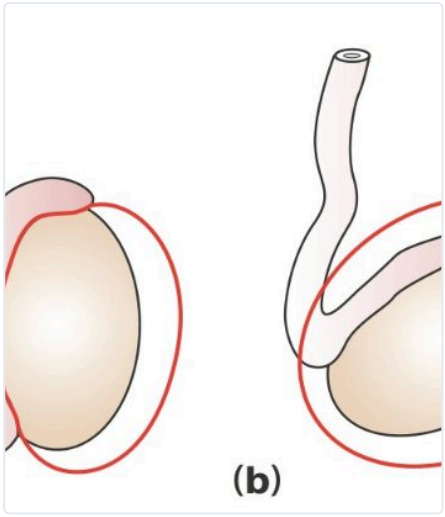
Máxima rentabilidad · ventana de 6 horas, fijación bilateral y reflejo cremastérico

4.03.2.007 **Torsión testicular** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Ecotomografía testicular · Testículo agudo

LO QUE TE PREGUNTAN

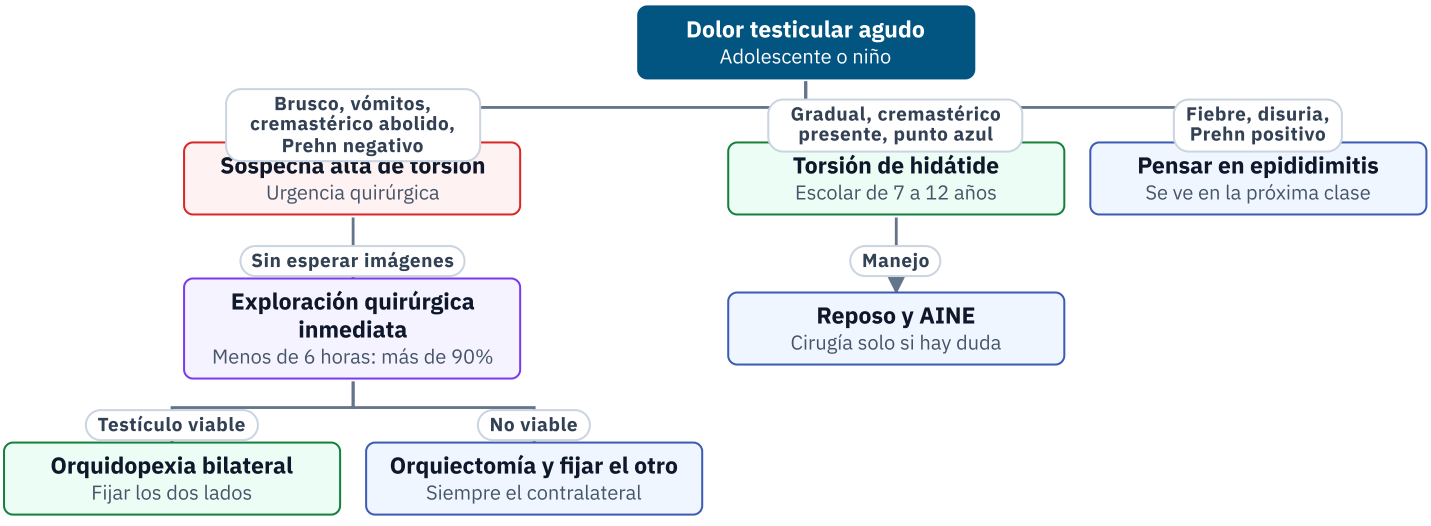
- La torsión testicular es una urgencia quirúrgica tiempo-dependiente: viabilidad >**90%** si se opera < **6 horas**.
- El reflejo cremastérico abolido es el signo físico más sensible (>**95%**) de torsión testicular.
- **Testículo ascendido y horizontalizado** = Signo de Gouverneur positivo.
- La elevación del testículo NO alivia el dolor en la torsión (Signo de Prehn negativo).
- La sospecha clínica alta de torsión obliga a exploración quirúrgica urgente sin dilación por ecografía.
- La torsión de hidátide de Morgagni presenta reflejo cremastérico presente y el signo del punto azul; se maneja con reposo y AINEs.
- La orquidopexia bilateral es mandatoria en la cirugía de torsión por la presencia bilateral de deformidad en badajo de campana.



NORMAL (A) Y BADAJO (B)
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 80.4

ALGORITMO · ESCROTO AGUDO: TORSIÓN O HIDÁTIDE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Urología**, preguntas **26–31** (págs. 11–12) · solucionario pág. 26.

Clase 13.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · URGENCIAS UROLÓGICAS & ESCROTO AGUDO

13.5 Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 13.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL ESCROTO AGUDO EN PEDIATRÍA Y ADULTO JOVEN

PARÁMETRO CLÍNICO	TORSIÓN TESTICULAR	TORSIÓN DE HIDÁTIDE	EPIDIDIMITIS AGUDA
Edad más frecuente	12 a 18 años (y periodo neonatal)	7 a 12 años	Adultos sexualmente activos / >35 a
Forma de inicio del dolor	Brusco, súbito e hiperagudo	Gradual a subagudo	Progresivo (horas a días)
Síntomas vegetativos (vómitos)	Muy frecuentes (> 50%)	Infrecuentes o ausentes	Raros (predomina fiebre y disuria)
Posición del testículo	Elevado y horizontalizado (Gouverneur +)	Posición normal anatómica	Normal o descendido por tumefacción
Reflejo cremastérico	ABOLIDO / Ausente (> 95%)	CONSERVADO / Presente	CONSERVADO / Presente
Signo de Prehn (elevación)	Negativo (no alivia o empeora)	Indiferente	POSITIVO (alivia el dolor)
Signo del punto azul	Ausente	Patognomónico en polo superior	Ausente
Flujo en Eco Doppler	Flujo arterial ausente o abolido	Flujo testicular normal; halo inflamatorio	Flujo aumentado (hiperemia marcada)
Conducta inmediata	Pabellón quirúrgico de urgencia <6h	Manejo médico con reposo y AINEs	Antibióticos según etiología + reposo

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Adolescente, dolor brusco, vómitos	Exploración quirúrgica	Pedir ecografía primero
Cremastérico abolido	Torsión del cordón	Pensar en epididimitis
Prehn negativo	Torsión: no alivia	Confundirlo con epididimitis

REGLA DE ORO **Todo testículo agudo se explora** — Menos de 6 horas: más de 90%

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La torsión del cordón espermático es una catástrofe vascular que conduce al infarto hemorrágico y necrosis del testículo por estrangulación del flujo venoso y arterial. El tiempo es el factor pronóstico determinante: la tasa de salvamento testicular es del 90-100% si se explora en las primeras 6 horas, cayendo a menos del 20-50% a las 12 horas y prácticamente 0% tras 24 horas. La regla de oro mandatoria es que jamás se debe retrasar la cirugía por esperar un estudio ecográfico si este no se puede realizar de forma instantánea. Además, la orquidopexia bilateral es obligatoria porque la anomalía en 'badajo de campana' es bilateral en más del 80% de los varones.

TABLA 13.5.B · TIEMPOS QUIRÚRGICOS Y CONDUCTA INTRAOPERATORIA EN TORSIÓN TESTICULAR

TIEMPO QUIRÚRGICO	ACCIÓN QUIRÚRGICA ESPECÍFICA	RACIONALIDAD FISIOPATOLÓGICA Y PRONÓSTICO
1. Incisión y Exteriorización	Incisión escrotal, apertura de vaginal y exteriorización gonadal	Acceso inmediato para liberar estrangulamiento vascular funicular
2. Destorsión Manual	Giro del testículo habitualmente hacia lateral (de medial a lateral)	Restablecer perfusión antes de evaluar viabilidad tisular definitiva
3. Calentamiento y Observación	Compresas tibias con solución salina por 10 a 15 minutos	Permite recuperación celular y diferenciación de tejido viable vs necrótico
4. Decisión: Conservar vs Extirpar	Si reperfunde: Orquidopexia con 3 puntos no reabsorbibles · Si no reperfunde: Orquiectomía	Prevenir atrofia y reacción inmunológica contra el testículo contralateral
5. Orquidopexia Contralateral Obligatoria	Apertura del hemiescroto contralateral y fijación del testículo sano	La anomalía anatómica en badajo de campana es bilateral en más del 80%

PRACTICA **Libro Gordo Urología**, preguntas **26–31** (págs. 11–12) · solucionario pág. 26.

Clase 13.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · URGENCIAS UROLÓGICAS & ESCROTO AGUDO

13.6 Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo

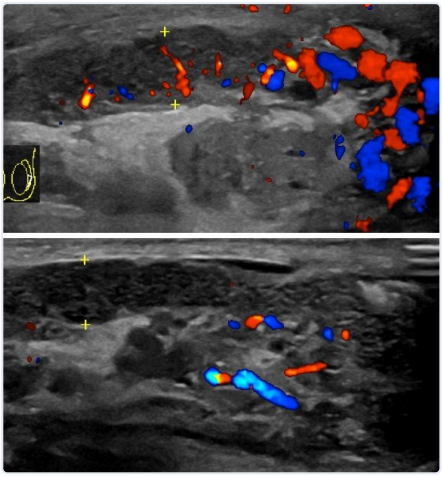
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

4.03.1.007 Epididimitis — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Enfermedades de transmisión sexual

LO QUE TE PREGUNTAN

- La epididimitis es de inicio subagudo (días) y cursa con reflejo cremastérico presente y Signo de Prehn positivo (alivia con elevación).
- En < **35 años** la etiología dominante es ETS (C. trachomatis y N. gonorrhoeae): Ceftriaxona IM + Doxiciclina VO.
- En > **35 años** la etiología predominante son uropatógenos entéricos (E. coli): Ciprofloxacino o Cotrimoxazol.
- En varones que practican coito anal insertivo debe cubrirse tanto entéricos como ETS.
- El tratamiento incluye siempre suspensorio escrotal, reposo en cama, frío local y AINEs.
- Fiebre persistente o empeoramiento tras **72 h** de antibióticos obliga a descartar absceso epididimario mediante ecografía.



EPIDÍDIMO HIPERVASCULAR
Wikimedia Commons, CC0

ALGORITMO · ORQUIEPIDIDIMITIS: EDAD Y ANTIBIÓTICO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

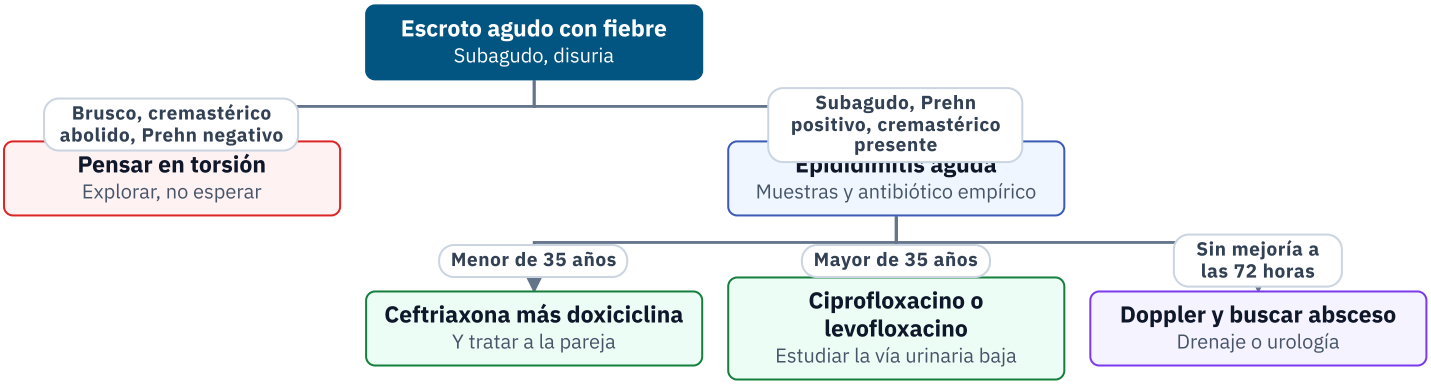


TABLA 13.6 · PROTOCOLO ANTIMICROBIANO EN ORQUIEPIDIDIMITIS AGUDA SEGÚN GRUPO DE RIESGO

GRUPO CLÍNICO	PATÓGENOS HABITUALES	ESQUEMA ANTIBIÓTICO DE 1ª LÍNEA	DURACIÓN Y MEDIDAS ADICIONALES
Varones < 35 años (ETS)	Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae	Ceftriaxona 500 mg IM (dosis única) + Doxiciclina 100 mg c/12h VO	10 a 14 días · Notificación ENO · Tratamiento simultáneo a parejas sexuales
Varones > 35 años / Instrumentados	Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus	Ciprofloxacino 500 mg c/12h VO o Levofloxacino 500 mg/d VO	10 a 14 días · Estudio urológico ambulatorio de vía urinaria baja (HPB)
Hombres que tienen sexo con hombres (coito anal receptivo)	Enterobacterias + Chlamydia + Gonococo	Ceftriaxona 500 mg IM + Ciprofloxacino 500 mg c/12h VO	14 días · Cobertura combinada para entéricos y gérmenes de transmisión sexual
Cuadro Séptico o Absceso	Flora polimicrobiana nosocomial o resistente	Hospitalización + Ceftriaxona 2 g/d EV o Ampicilina/Sulbactam	Drenaje quirúrgico si hay colección fluctuante en ecografía

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Menor de 35, sexualmente activo	Ceftriaxona más doxiciclina	Ciprofloxacino solo
Mayor de 35 o con HPB	Ciprofloxacino o levofloxacino	Pensar en Chlamydia
Prehn positivo, cremastérico presente	Epididimitis	Pensar en torsión

REGLA DE ORO **Subaguda, fiebre, Prehn positivo** — Cremastérico presente

PRACTICA **Libro Gordo Urología**, preguntas **32–36, 55** (págs. 12–13, 16) · solucionario págs. 27, 30.

Clase 13.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · URGENCIAS UROLÓGICAS & ESCROTO AGUDO

13.7 Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

4.03.1.028 Varicocele — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

También: Hidrocele · Quistes del epidídimo · Criptorquidia

LO QUE TE PREGUNTAN

- La transiluminación positiva confirma contenido líquido claro seroso: hidrocele o espermatocele.
- En el hidrocele el líquido rodea todo el testículo; en el espermatocele la masa quística está separada en el epidídimo.
- El varicocele es la dilatación del plexo pampiniforme ('bolsa de gusanos') y el **90%** es del lado izquierdo.
- El varicocele es la causa tratable más frecuente de infertilidad y oligoastenospermia en el varón.
- Varicocele derecho, de inicio súbito en adultos mayores o que no colapsa en decúbito es una BANDERA ROJA de tumor renal.



VARICOCELE IZQUIERDO
Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 4260

ALGORITMO · MASA ESCROTAL INDOLORA

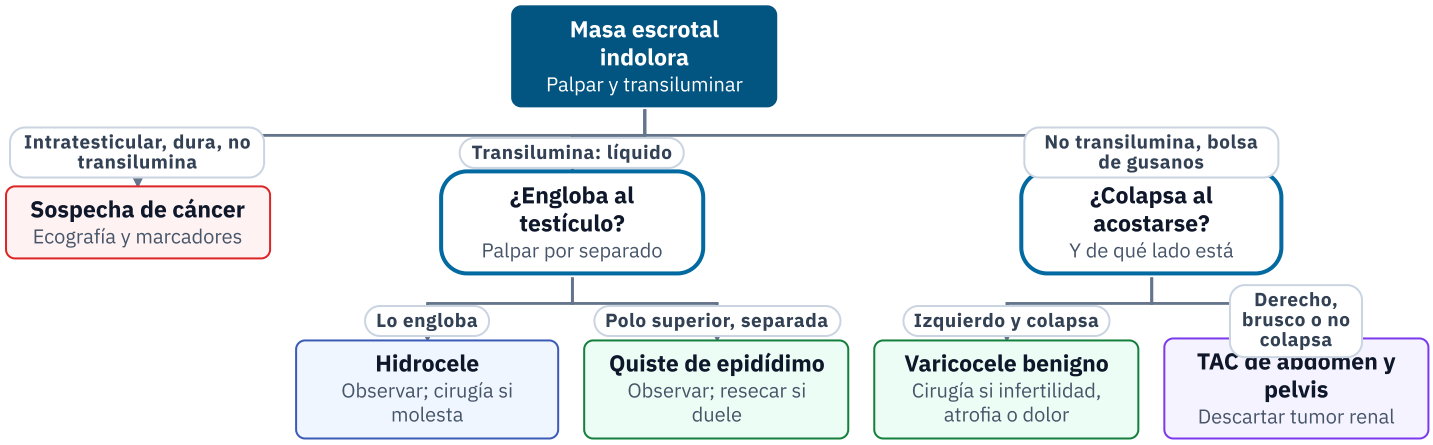


TABLA 13.7 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MASAS ESCROTALES INDOLORAS

PATOLOGÍA	LOCALIZACIÓN RESPECTO AL TESTÍCULO	CONSISTENCIA Y PALPACIÓN	TRANSILUMINACIÓN	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Hidrocele Adquirido	Rodea y engloba al testículo (intravaginal)	Fluctuante, lisa, redondeada, no reductible	POSITIVA (+)	Observación si es pequeño · Hidrocelectomía si molesta
Espermatocele / Quiste Epididimario	Polo superior, claramente separado del testículo	Quística, tensa, móvil, indolora	POSITIVA (+)	Observación y tranquilidad; resección solo si es doloroso
Varicocele Benigno	Posterior y superior al testículo (izquierdo)	Sensación de 'bolsa de gusanos', colapsa en decúbito	NEGATIVA (-)	Varicocelectomía si causa infertilidad, atrofia o dolor
Varicocele Secundario (Bandera Roja)	Derecho, de inicio brusco o fijo en decúbito	No colapsa al acostar al paciente	NEGATIVA (-)	TAC de abdomen urgente: descartar tumor renal / trombo cava
Cáncer de Testículo	Intratesticular propio (parénquima)	Pétrea, dura, irregular, indolora, no colapsa	NEGATIVA (-)	Eco Doppler + Marcadores tumorales + Orquiectomía inguinal

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Varicocele derecho que no colapsa	TAC de abdomen y pelvis	Operar o tranquilizar
Adolescente con atrofia y dolor	Varicocelectomía	Esperar la pubertad
Masa que transilumina	Hidrocele o quiste	Pensar en tumor

REGLA DE ORO **Linterna: líquido o sólido** — Positiva: hidrocele o quiste

PRACTICA **Libro Gordo Urología**, preguntas **38, 40–45** (págs. 13–14) · solucionario págs. 27–28.

Clase 13.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · URGENCIAS UROLÓGICAS & ESCROTO AGUDO

13.16 Patología Peneana: Fimosis, Parafimosis, Balanopostitis, Priapismo & Disfunción Eréctil

★★★ PRIORIDAD ALTA
11 preguntas reales 2013–2025

Alta rentabilidad · fimosis fisiológica que se observa, balanopostitis que obliga a pedir glicemia, fenilefrina en el priapismo isquémico e iPDE5 con contraindicación absoluta de nitratos

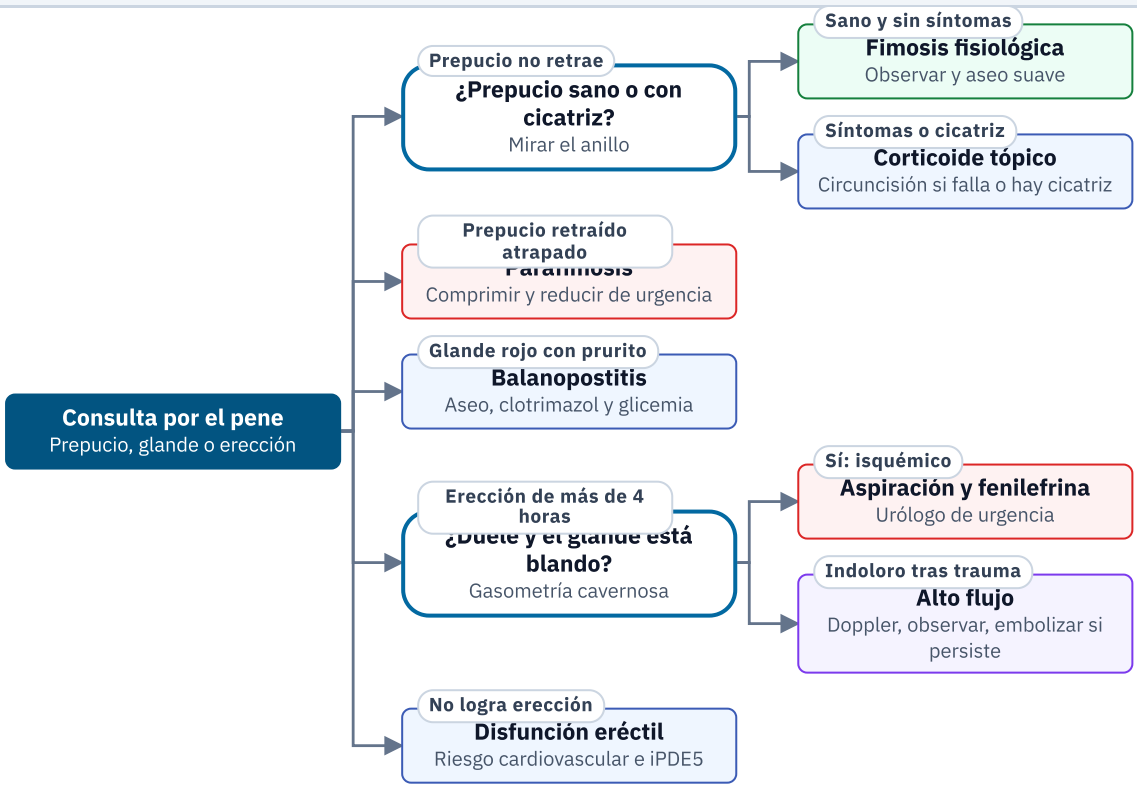
4.03.1.009 **Fimosis, parafimosis** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

También: Balanitis, balano postitis · Priapismo · Disfunción sexual de causa orgánica · Parafimosis · Reducción de parafimosis

LO QUE TE PREGUNTAN

- La fimosis fisiológica del niño, con prepucio sano y sin cicatriz, se observa: nunca se retrae a la fuerza.
- **Fimosis sintomática**: corticoide tópico **4 a 8 semanas**; circuncisión si es cicatricial, falla el corticoide o hay balanopostitis o ITU recurrente.
- **La parafimosis es una urgencia**: compresión del edema y reducción manual; si falla, incisión dorsal. Siempre reponer el prepucio tras sondear.
- **Balanopostitis candidiásica (pápulas satélites)**: clotrimazol tópico y glicemia; si no responde en **4 a 6 semanas**, biopsia.
- **Priapismo isquémico (doloroso, glande blando, sangre oscura)**: aspiración + fenilefrina intracavernosa y derivación urgente; el hielo no sirve.
- Priapismo no isquémico (post trauma perineal, indoloro, sangre roja): no es urgencia; observación y embolización si persiste.
- La disfunción eréctil orgánica es vascular y anticipa la enfermedad coronaria: siempre evaluar el riesgo cardiovascular.

ALGORITMO · PATOLOGÍA PENEANA



PRACTICA **Libro Gordo Urología**, preguntas **1–3, 21, 37** (págs. 8, 11, 13) · solucionario págs. 22, 25, 27.

Clase 13.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · URGENCIAS UROLÓGICAS & ESCROTO AGUDO

13.16 Patología Peneana: Fimosis, Parafimosis, Balanopostitis, Priapismo & Disfunción Eréctil

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 13.16 · PATOLOGÍA DEL PREPUCIO Y DEL GLANDE: DIAGNÓSTICO Y CONDUCTA

ENTIDAD	DATO CLÍNICO CLAVE	CONDUCTA DEL MÉDICO GENERAL	CUÁNDO DERIVAR
Fimosis fisiológica	Niño, prepucio sano y flexible, sin anillo cicatricial	Observar · aseo suave · NO retraer a la fuerza	Si se vuelve sintomática o cicatricial
Fimosis sintomática	Balanopostitis, ITU o abombamiento con dificultad miccional	Betametasona 0,05% tópica 4 a 8 semanas	Fracaso del corticoide: circuncisión
Fimosis cicatricial / liquen escleroso	Anillo blanquecino, fibroso e inelástico	Derivar (circuncisión) · en el adulto pedir glicemia	Siempre
Parafimosis	Prepucio retraído con anillo constrictor y glande edematoso	URGENCIA: analgesia, compresión del edema y reducción manual	Si falla: incisión dorsal · circuncisión diferida
Balanopostitis candidiásica	Eritema con pápulas satélites y exudado blanco	Clotrimazol 1% 7 a 14 días · fluconazol 150 mg si es extensa · GLICEMIA	Sin respuesta en 4 a 6 semanas: biopsia
Balanopostitis bacteriana (niño)	Prepucio rojo y edematoso, a veces con pus; sin fiebre	Baños de asiento y aseo · antibiótico oral si hay celulitis	Recurrente: circuncisión

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Prepucio atrapado tras sonda	Comprimir y reducir	Circuncisión de urgencia o calor
Balanopostitis en adulto	Antifúngico y glicemia	Tratar sin buscar diabetes
Erección dolorosa, glande blando	Aspiración y fenilefrina	Hielo u observar
Erección indolora post trauma	Doppler y observar	Fenilefrina o shunt
Usuario de sildenafil con dolor torácico	No dar nitratos	Nitroglicerina sublingual

REGLA DE ORO **Fimosis sana del niño: observar** — Corticoide si hay síntomas

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El pene concentra cuatro situaciones que el médico general debe resolver o derivar a tiempo. La fimosis del niño casi siempre es fisiológica y solo se observa; su complicación aguda, la parafimosis, es una urgencia que se reduce manualmente. La balanopostitis del adulto es candidiásica con mayor frecuencia y obliga a descartar diabetes. El priapismo isquémico es un síndrome compartimental de los cuerpos cavernosos: sobre las 4 horas cada hora suma fibrosis y riesgo de disfunción eréctil definitiva, y se trata con aspiración y fenilefrina intracavernosa. La disfunción eréctil orgánica es vascular en la mayoría de los casos y anticipa en años la enfermedad coronaria; su primera línea son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, contraindicados con nitratos.

TABLA 13.16.B · DISFUNCIÓN ERÉCTIL ORGÁNICA: ESTUDIO Y TRATAMIENTO ESCALONADO

ESCALÓN	MEDIDA	CLAVE DE EXAMEN
Estudio inicial	Historia sexual y de fármacos · glicemia o HbA1c · perfil lipídico · testosterona total matinal	Es un marcador de riesgo cardiovascular: estratificarlo
Medidas generales	Dejar de fumar, ejercicio, baja de peso, control de DM, HTA y dislipidemia · cambiar el fármaco causante	Betabloqueadores, tiazidas, espironolactona, ISRS y antiandrógenos causan DE
1ª línea	iPDE5: sildenafil 50 mg 1 h antes · tadalafil 10 a 20 mg a demanda o 5 mg diario	Contraindicación absoluta: nitratos (24 h sildenafil, 48 h tadalafil)
Hipogonadismo confirmado	Testosterona (con LH, FSH y prolactina previos)	Nunca testosterona sin hipogonadismo demostrado
2ª línea (urólogo)	Alprostadil intracavernoso o intrauretral · dispositivo de vacío	El alprostadil puede causar priapismo
3ª línea (urólogo)	Prótesis de pene	Ante fracaso de las anteriores

PRACTICA **Libro Gordo Urología**, preguntas **1–3, 21, 37** (págs. 8, 11, 13) · solucionario págs. 22, 25, 27.

Clase 13.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · URO-ONCOLOGÍA

13.8 Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason

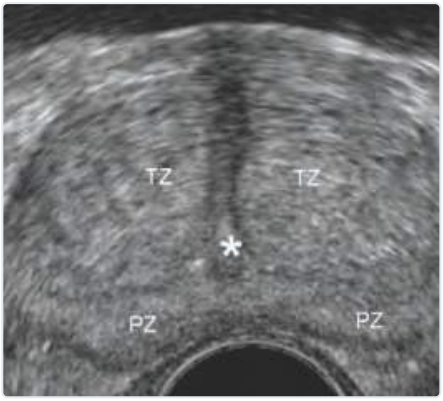
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

4.03.1.002 Cáncer de próstata — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Screening de cáncer de próstata · Antígeno prostático específico · Biopsia prostática · Cintigrafía ósea y cintigrafía con galio · Epidemiología del cáncer de próstata

LO QUE TE PREGUNTAN

- El cáncer de próstata se origina en un **70-80%** en la zona periférica posterior de la glándula.
- Tacto rectal con nódulo pétreo indurado es indicación OBLIGATORIA de biopsia, independientemente del nivel de APE.
- **El APE es órgano-específico pero no cáncer-específico**: se eleva por HPB, prostatitis aguda y retención.
- En la 'zona gris' del APE (4 a 10 ng/mL), un % de APE Libre / Total menor al **15%** orienta fuertemente a cáncer.
- La confirmación diagnóstica definitiva se obtiene exclusivamente mediante biopsia transrectal ecoguiada (10-12 cilindros).



ECO TRANSRECTAL NORMAL
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 75.17a

ALGORITMO · SOSPECHA DE CÁNCER DE PRÓSTATA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

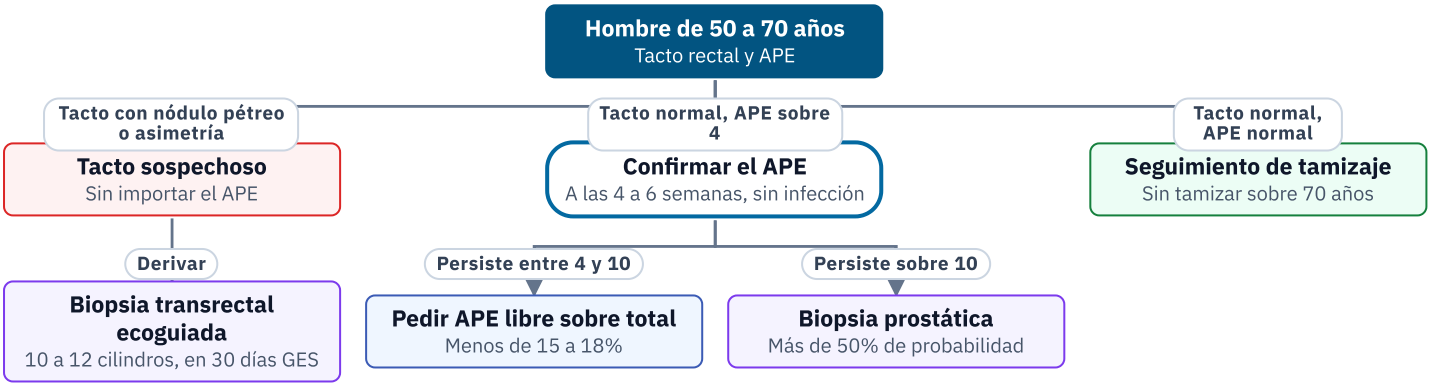


TABLA 13.8 · CINÉTICA Y PARÁMETROS DEL APE EN LA SOSPECHA DE CÁNCER PROSTÁTICO

PARÁMETRO / PRUEBA	DEFINICIÓN Y RANGO NORMAL	CRITERIO DE SOSPECHA DE CAP	UTILIDAD CLÍNICA EN TOMA DE DECISIONES
APE Total Absoluto	Normal general: < 4.0 ng/mL	APE > 4.0 ng/mL (o >10 ng/mL alto riesgo)	Marcador inicial de tamizaje · Valores >10 ng/mL tienen >50% de probabilidad de CaP
Porcentaje APE Libre / Total	Normal: > 20 - 25% libre	APE Libre / Total < 15 - 18%	Diferencia HPB de CaP en 'zona gris' (4-10 ng/mL): menor fracción libre indica CaP
Densidad del APE (D-PSA)	APE total / Volumen ecográfico prostático	Densidad > 0.15 ng/mL/cc	Distingue elevación por próstata gigante benigna vs neoplasia focalizada
Velocidad del APE (V-PSA)	Incremento anual en al menos 3 tomas	Aumento > 0.75 ng/mL en 1 año	Sugiere proliferación maligna activa incluso con valores absolutos basales normales
Tacto Rectal Anormal	Próstata lisa fibroelástica simétrica	Nódulo pétreo / asimetría / consistencia dura	Indicación directa de biopsia prostática independiente del valor del APE

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Nódulo pétreo y APE normal	Biopsia	Tranquilizar por el APE
APE alto con infección urinaria	Tratar y repetir	Biopsiar sin repetir
APE entre 4 y 10	APE libre sobre total	Mandar a cirugía

REGLA DE ORO **Nódulo pétreo: biopsia siempre** — Aunque el APE sea normal

PRACTICA **Libro Gordo Urología**, preguntas **46–51** (págs. 14–15) · solucionario pág. 29.

Clase 13.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · URO-ONCOLOGÍA

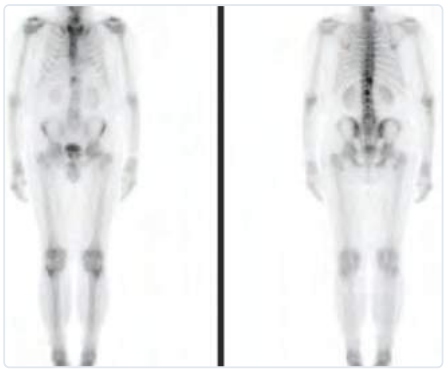
13.9 Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia)

★★☆
PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

4.03.1.002 Cáncer de próstata — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- En cáncer de próstata de bajo riesgo con expectativa de vida limitada la Vigilancia Activa es la elección.
- Prostatectomía radical y Radioterapia externa tienen idéntica sobrevida global en tumores localizados.
- Las secuelas típicas de la cirugía son la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria.
- La radioterapia externa puede producir proctitis y cistitis actínica a mediano y largo plazo.
- Las metástasis del cáncer de próstata son característicamente osteoblásticas (densas) y se detectan con cintigrama óseo.



POCOS FOCOS (BAJO VOLUMEN)
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 75.27a

ALGORITMO · TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

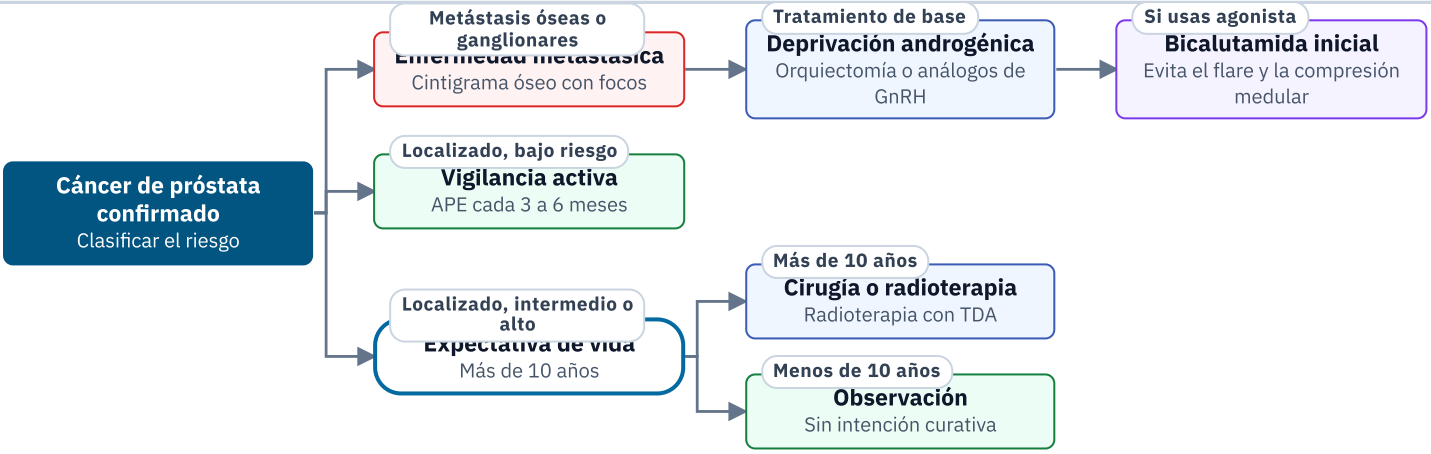


TABLA 13.9 · COMPARATIVA DE MODALIDADES TERAPÉUTICAS EN CÁNCER DE PRÓSTATA

MODALIDAD TERAPÉUTICA	ESCENARIO CLÍNICO INDICADO	MECANISMO / INTERVENCIÓN	PRINCIPALES EFECTOS SECUNDARIOS
Vigilancia Activa	Bajo riesgo (ISUP 1, APE < 10, cT1-T2a)	Monitoreo seriado con APE, TR y rebiopsias	Ansiedad del paciente; riesgo de pérdida de seguimiento
Prostatectomía Radical	Riesgo intermedio/alto localizado; expectativa >10 a	Extirpación quirúrgica completa de la glándula y vesículas	Disfunción eréctil (30-70%), incontinencia urinaria (5-10%)
Radioterapia Externa + TDA	Riesgo intermedio o alto localizado/localmente avanzado	Radiación ionizante guiada + Bloqueo hormonal 6 a 36 m	Proctitis actínica, cistitis por radiación, sofocos, astenia
Castración Médica (TDA)	Enfermedad metastásica M1 (ósea/ganglionar)	Análogos LHRH (Leuprolide) o Antagonistas (Degarelix)	Pérdida de libido, osteoporosis, síndrome metabólico, ginecomastia
Antiandrógenos de Nueva Generación	CaP resistente a la castración (CPRC)	Enzalutamida, Abiraterona, Apalutamida	Fatiga, hipertensión, fracturas, toxicidad hepática (abiraterona)

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Gleason 6 o tumor mínimo en adulto mayor	Vigilancia u observación	Operar o irradiar
Localizado, 20 años de vida	Cirugía o radioterapia	Hormonas solas
Metástasis ósea	Deprivación androgénica	Cirugía radical

REGLA DE ORO **Bajo riesgo o adulto mayor: vigilancia** — No se sobretrata

PRACTICA **Libro Gordo Urología**, preguntas **52–54** (pág. 15) · solucionario págs. 29–30.

Clase 13.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · URO-ONCOLOGÍA

13.10 Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

4.03.1.024 Tumor testicular — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Ecotomografía testicular · Epidemiologia del cáncer testicular · Criptorquídea

LO QUE TE PREGUNTAN

- Toda masa intratesticular sólida en un varón de **15 a 35 años** es maligna hasta demostrar lo contrario.
- La criptorquidia es el principal factor de riesgo para cáncer testicular (aumenta riesgo **4 a 10 veces**).
- La ecografía testicular Doppler es el examen de imagen de elección con sensibilidad cercana al **100%**.
- Los marcadores tumorales séricos (AFP, b-hCG, LDH) deben tomarse SIEMPRE antes de extirpar el testículo.
- El seminoma puro NUNCA eleva Alfafetoproteína (AFP); si la AFP está elevada, es un No Seminoma.



NÓDULO HIPOECOGÉNICO
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 80.16

ALGORITMO · MASA TESTICULAR INDOLORA EN VARÓN JOVEN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

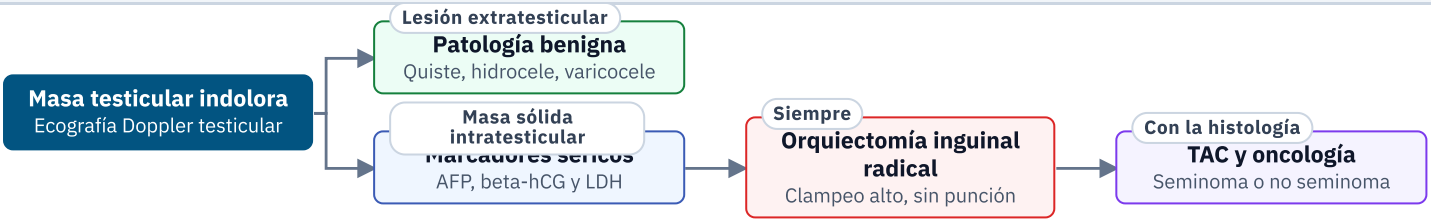


TABLA 13.10 · PERFIL DE MARCADORES TUMORALES EN CÁNCER DE TESTÍCULO

SUBTIPO HISTOLÓGICO TUMORAL	ALFAFETOPROTEÍNA (AFP)	GONADOTROFINA CORIÓNICA (B-HCG)	DESHIDROGENASA LÁCTICA (LDH)	SENSIBILIDAD RADIOTERÁPICA
Seminoma Puro	SIEMPRE NORMAL (0%)	Elevada en 15 - 20%	Elevada en enfermedad voluminosa	ALTA (Radiosensible)
Carcinoma Embrionario	Elevada en 60 - 70%	Elevada en 60%	Frecuentemente elevada	BAJA (Radiorresistente)
Tumor del Saco Vitelino (Yolk Sac)	ELEVADA (> 90%)	Normal (0%)	Elevada	BAJA (Radiorresistente)
Coriocarcinoma Puro	Normal (0%)	MASIVAMENTE ELEVADA (>99%)	Muy elevada (metástasis hematógenas)	Radiorresistente (quimiosensible)
Teratoma Maduro / Inmaduro	Normal	Normal	Normal	Radiorresistente (quirúrgico)

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Masa sólida intratesticular	Orquiectomía inguinal	Punción o vía escrotal
Sospecha de tumor	Marcadores antes de operar	Pedirlos después
"Seminoma" con AFP alta	Tratar como no seminoma	Tratar como seminoma

REGLA DE ORO **Masa intratesticular: maligna hasta probar** — Ecografía Doppler y marcadores

PRACTICA **Libro Gordo Urología**, preguntas **19, 60–63** (págs. 10, 16–17) · solucionario págs. 25, 31.

Clase 13.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · URO-ONCOLOGÍA

13.11 Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía

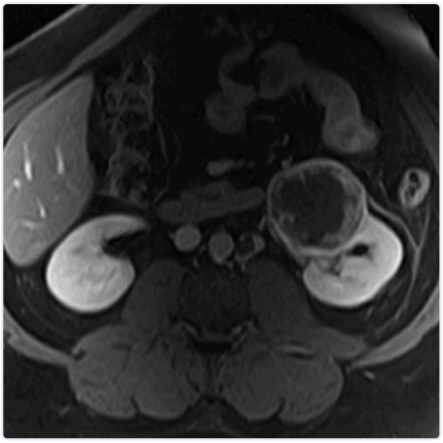
★★★ PRIORIDAD ALTA
7 preguntas reales 2013–2025

4.03.1.022 Tumor renal — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: TAC de abdomen y pelvis · Tumores sólidos

LO QUE TE PREGUNTAN

- Más del **65%** de los tumores renales se pesquisan como incidentalomas asintomáticos en ecografía o TAC.
- La clásica tríada de Guyon (dolor lumbar, hematuria y masa palpable) denota enfermedad avanzada (< **10%** de los casos).
- El Carcinoma de Células Claras es el subtipo más frecuente (**80%**) y se asocia a la pérdida del gen VHL.
- El criterio diagnóstico tomográfico de malignidad es el realce significativo tras contraste (> 15-20 UH).
- La biopsia percutánea NO se realiza de rutina ante una masa renal resecable típica.
- Para tumores T1 (**≤ 4 cm**, hasta **7 cm**) la nefrectomía parcial es el estándar de oro para preservar masa renal funcionante.



MASA RENAL QUE REALZA
CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 362

ALGORITMO · MASA RENAL SÓLIDA HALLADA EN ECOGRAFÍA

☐ urgencia ☐ resuelve ☐ derivar ☐ examen/acción



TABLA 13.11 · SUBTIPOS HISTOLÓGICOS DE CÁNCER RENAL Y SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS ASOCIADOS

SUBTIPO HISTOLÓGICO / SÍNDROME	FRECUENCIA	CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS / CLÍNICAS	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Carcinoma de Células Claras	75 - 80%	Células con citoplasma claro rico en lípidos · Mutación gen VHL (3p)	Nefrectomía parcial o radical · Antiangiogénicos (TKI) si es metastásico
Carcinoma Papilar (Tipo 1 y 2)	10 - 15%	Arquitectura papilar · Mutación oncogén MET · Multifocal en ocasiones	Nefrectomía con preservación nefronal si es posible
Carcinoma Cromófobo	5%	Células poligonales eosinófilas · Excelente pronóstico oncológico	Cirugía curativa de resección; baja tasa de metástasis
Síndrome de Stauffer	Paraneoplásico	Fosfatasas alcalinas elevadas, transaminasas alteradas e ictericia sin metástasis	Disfunción hepática reversible que cura al extirpar el tumor renal
Hipercalcemia Paraneoplásica	Paraneoplásico	Producida por secreción ectópica de péptido PTHrP tumoral	Hidratación + Bifosfonatos + Nefrectomía del primario

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Masa renal sólida en ecografía	TAC trifásico	Biopsia percutánea
Dolor, hematuria y masa	Enfermedad avanzada	Esperar la tríada
Hipercalcemia con tumor	Medir PTH	Dar por hecho hiperparatiroidismo

REGLA DE ORO **Masa sólida: TAC trifásico** — Realce mayor a 15-20 UH

PRACTICA **Libro Gordo Urología**, preguntas **64–66** (pág. 17) · solucionario págs. 31–32.

Clase 13.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · URO-ONCOLOGÍA

13.12 Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV

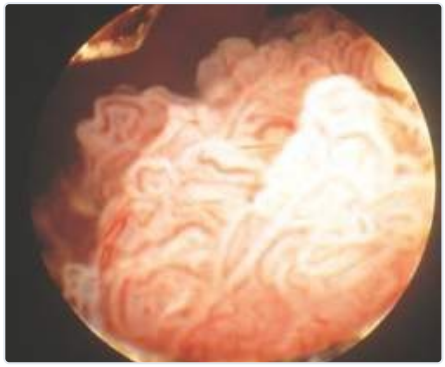
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

4.03.1.003 Cáncer de vejiga y urotelio — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Cistoscopia · Hematuria

LO QUE TE PREGUNTAN

- La hematuria macroscópica indolora en fumadores > **50 años** es cáncer vesical hasta demostrar lo contrario.
- El tabaquismo es el factor etiológico más importante de cáncer de vejiga (carcinoma urotelial).
- La Cistoscopía es el examen diagnóstico confirmatorio directo de referencia.
- La Resección Transuretral de Vejiga (RTUV) es el procedimiento inicial diagnóstico y terapéutico.
- La presencia de músculo detrusor en la biopsia es obligatoria para discernir entre no invasivo e invasivo.



TUMOR PAPILAR PTA
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 77.48

ALGORITMO · CÁNCER DE VEJIGA: DE LA HEMATURIA AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 13.12 · CLASIFICACIÓN DE CÁNCER DE VEJIGA: NO MÚSCULO INVASIVO VS MÚSCULO INVASIVO

CARACTERÍSTICA	NO MÚSCULO INVASIVO (CVNMI)	MÚSCULO INVASIVO (CVMI)
Estadios TNM	Ta (mucosa), Tis (CIS plano), T1 (lámina propia)	T2a-T2b (muscular propia), T3 (grasa perivesical), T4 (órganos vecinos)
Frecuencia al diagnóstico	Aproximadamente el 75%	Aproximadamente el 25%
Aspecto Cistoscópico	Papilar, vegetante, digitiforme (frondas de helecho)	Sólido, sésil, ulcerado, invasor en profundidad
Tratamiento Inicial de Elección	Resección Transuretral de Vejiga (RTUV) completa	Quimioterapia neoadyuvante con Cisplatino + Cistectomía Radical
Tratamiento Adyuvante	Instilaciones intravesicales con BCG o Mitomicina C	Linfadenectomía pélvica extendida + Derivación urinaria (Bricker)
Riesgo Principal	Alta tasa de recidiva intravesical (50-70%)	Metástasis ganglionares y hematógenas rápidas; letalidad elevada

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Hematuria indolora, fumador	Cistoscopía	Tratar como infección
TAC normal y hematuria	Cistoscopía igual	Dar de alta
Resección sin músculo	Repetir o completar	Clasificar como superficial

REGLA DE ORO **Hematuria indolora en fumador** — Cáncer hasta probar lo contrario

PRACTICA **Libro Gordo Urología**, preguntas **67–72** (págs. 17–18) · solucionario pág. 32.

Clase 13.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · INFECCIONES UROLÓGICAS, QUISTES & HEMATURIA

13.13 Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

Alta rentabilidad · contraindicación absoluta del masaje prostático y antibióticos prolongados

4.03.2.005 **Prostatis aguda** — Dx Específico | Tx Completo | Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- La prostatitis bacteriana aguda cursa con fiebre alta, dolor perineal al sentarse y disuria intensa.
- Al tacto rectal la próstata está caliente, turgente y exquisitamente dolorosa.
- El MASAJE PROSTÁTICO está formalmente contraindicado en fase aguda por riesgo de bacteriemia y sepsis.
- Si se produce retención urinaria en prostatitis aguda, realizar CISTOSTOMÍA suprapúbica (no sonda Foley).
- Los antibióticos de elección son las Fluoroquinolonas (Ciprofloxacino) y Cotrimoxazol por su liposolubilidad.
- La duración del tratamiento en prostatitis aguda debe ser de al menos **3 a 4 semanas** para evitar cronicidad.

ALGORITMO · PROSTATITIS: DEL CUADRO FEBRIL AL TRATAMIENTO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

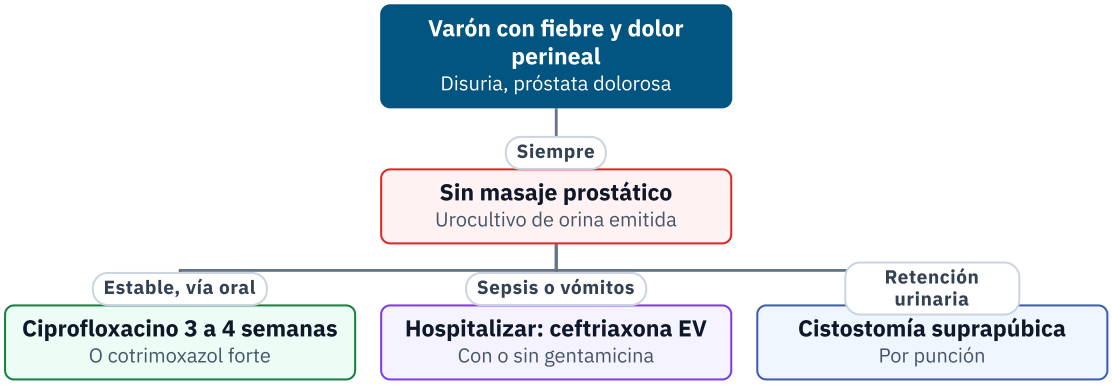


TABLA 13.13 · CLASIFICACIÓN NIH DE LOS SÍNDROMES DE PROSTATITIS Y MANEJO TERAPÉUTICO

CATEGORÍA NIH	DENOMINACIÓN CLÍNICA	HALLAZGOS EN CULTIVO / MICROSCOPÍA	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Categoría I	Prostatitis Bacteriana Aguda	Urocultivo positivo para uropatógenos entéricos (E. coli)	Ciprofloxacino oral x 3-4 semanas o Ceftriaxona EV si sepsis · Masaje PROHIBIDO
Categoría II	Prostatitis Bacteriana Crónica	ITUs recurrentes por el mismo clon bacteriano · Test de Meares-Stamey (+)	Fluoroquinolonas orales prolongadas por 6 a 12 semanas (Ciprofloxacino)
Categoría IIIa	SDPC Inflamatorio (No bacteriano)	Leucocitos en secreción prostática pero cultivos negativos estériles	Alfa-1 bloqueantes (Tamsulosina) + AINEs + Ensayo corto con antibiótico
Categoría IIIb	SDPC No Inflamatorio (Prostatodinia)	Sin leucocitos y sin bacterias; dolor miofascial perineal crónico	Neuromoduladores (Pregabalina), fisioterapia del piso pélvico y psicoterapia
Categoría IV	Prostatitis Asintomática	Leucocitos en biopsia prostática o semen sin clínica alguna	No requiere tratamiento médico (hallazgo inocuo)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Próstata caliente y dolorosa	Antibiótico, sin masaje	Masaje prostático
Duración	3 a 4 semanas	Siete días
Retención urinaria	Cistostomía suprapúbica	Sonda uretral
Dolor perineal, cultivos estériles	Pregabalina, fisioterapia	Más antibióticos

REGLA DE ORO **Fiebre, periné doloroso, próstata caliente** — Prostatitis aguda

PRACTICA **Libro Gordo Urología**, preguntas **75–79** (pág. 19) · solucionario págs. 33–34.

Clase 13.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · INFECCIONES UROLÓGICAS, QUISTES & HEMATURIA

13.14 Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante

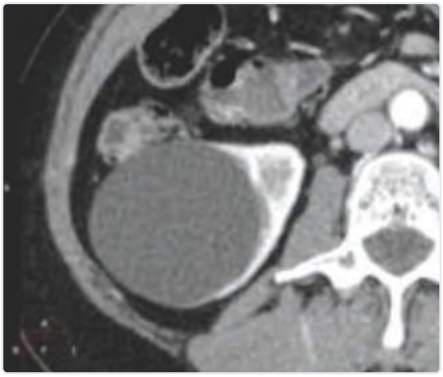
★☆☆
PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

4.03.1.018 Lesiones quísticas del riñón — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

También: Riñón poliquístico

LO QUE TE PREGUNTAN

- El quiste simple en ecografía es anecoico, de pared imperceptible y con refuerzo acústico: es benigno y no requiere control.
- **La escala de Bosniak clasifica quistes por TAC**: Bosniak I y II son benignos; Bosniak III y IV son quirúrgicos (cáncer quístico).
- Bosniak IIF requiere seguimiento tomográfico periódico por bajo riesgo de malignización (**~5%**).
- La PQRAD es autosómica dominante por mutación en PKD1 (cr 16, más severo) o PKD2 (cr 4).
- La PQRAD cursa con HTA precoz, nefromegalia palpable bilateral, hematuria y progresión a falla renal terminal.



QUISTE SIMPLE EN EL TAC
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 75.24 (panel de quiste simple)

ALGORITMO · QUISTES RENALES: DE LA ECOGRAFÍA A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

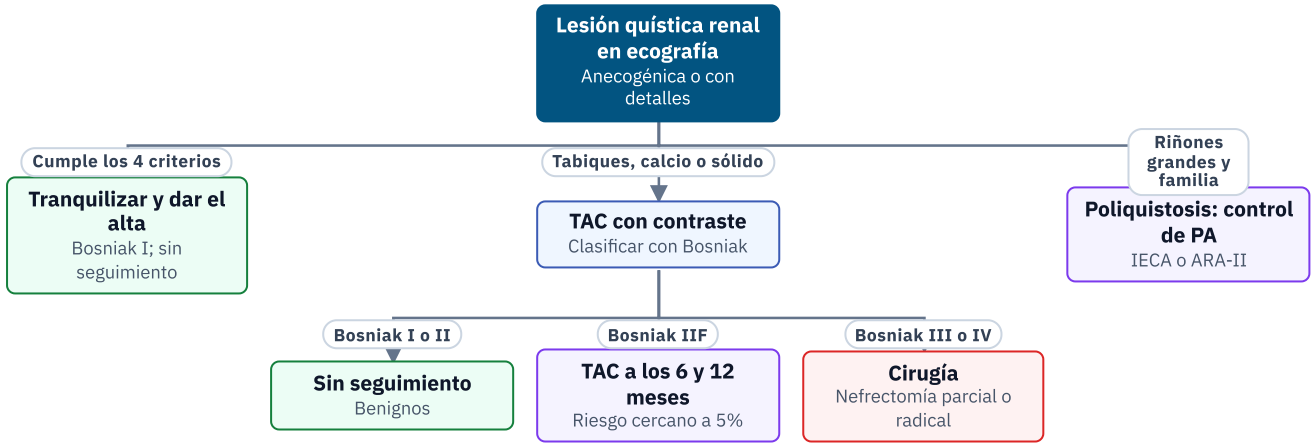


TABLA 13.14 · CLASIFICACIÓN TOMOGRÁFICA DE BOSNIAK PARA MASAS RENALES QUÍSTICAS

CATEGORÍA BOSNIAK	HALLAZGOS EN TAC CON CONTRASTE EV	RIESGO DE MALIGNIDAD	CONDUCTA CLÍNICA NORMADA
Bosniak I	Quiste simple benigno: pared fina como papel, densidad agua, sin tabiques ni realce	0% (Benigno)	Tranquilizar al paciente · No requiere seguimiento ni imágenes
Bosniak II	Tabiques delgados (< 1 mm), calcificaciones finas, quiste hiperdenso < 3 cm sin realce	0% (Benigno)	Benigno · No requiere seguimiento tomográfico
Bosniak IIF	Múltiples tabiques finos, leve engrosamiento parietal, hiperdenso > 3 cm sin realce	Aproximadamente 5%	Seguimiento con TAC contrastado a los 6 y 12 meses por 5 años
Bosniak III	Tabiques engrosados e irregulares con realce contrastado francamente medible	50 a 60%	Quirúrgico: Nefrectomía parcial nefro-preservadora o radical
Bosniak IV	Pared o tabiques con nódulos sólidos de partes blandas con realce marcado	85 a 100%	Quirúrgico: Resección oncológica (Carcinoma renal quístico)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Quiste anecogénico, pared fina	Alta sin control	Pedir TAC o punción
Tabiques o calcio en eco	TAC con contraste	Observar solamente
Poliquistosis + cefalea súbita	TAC cerebro urgente	Pensar en crisis hipertensiva

REGLA DE ORO **Quiste simple típico: alta** — Sin TAC ni control

PRACTICA **Libro Gordo Urología**, preguntas **80–85** (págs. 19–20) · solucionario págs. 34–35.

Clase 13.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · INFECCIONES UROLÓGICAS, QUISTES & HEMATURIA

13.15 Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas

★★★ PRIORIDAD ALTA
8 preguntas reales 2013–2025

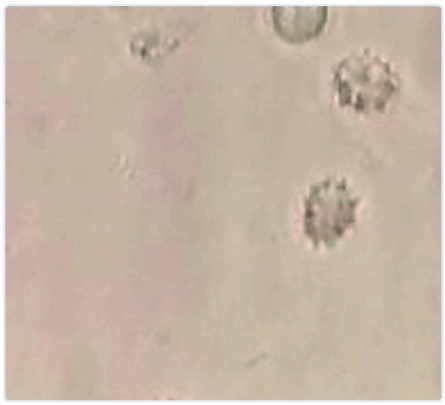
4.03.1.010
2.01.1.060
Hematuria

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Examen de orina completo, urocultivo · Síndrome nefrítico · Examen de orina y sedimento urinario · Examen de orina completa · Hematuria masiva

LO QUE TE PREGUNTAN

- La hematuria se define como **≥ 3 glóbulos** rojos por campo en sedimento de orina centrifugada.
- Toda tira reactiva positiva exige confirmación con sedimento microscópico para descartar mioglobinuria.
- La presencia de COÁGULOS descarta categóricamente el origen glomerular: es siempre urológica.
- Acantocitos (> **5%**), hematíes dismórficos (> **80%**) y cilindros hemáticos certifican origen glomerular.
- Hematuria glomerular cursa con orina color té/coca-cola y frecuentemente asocia proteinuria > **500 mg**/d.



HEMATÍES DISMÓRFICOS
Manual CTO Nefrología 14.ª ed., p. 33

ALGORITMO · HEMATURIA: DE LA CONFIRMACIÓN AL DESTINO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

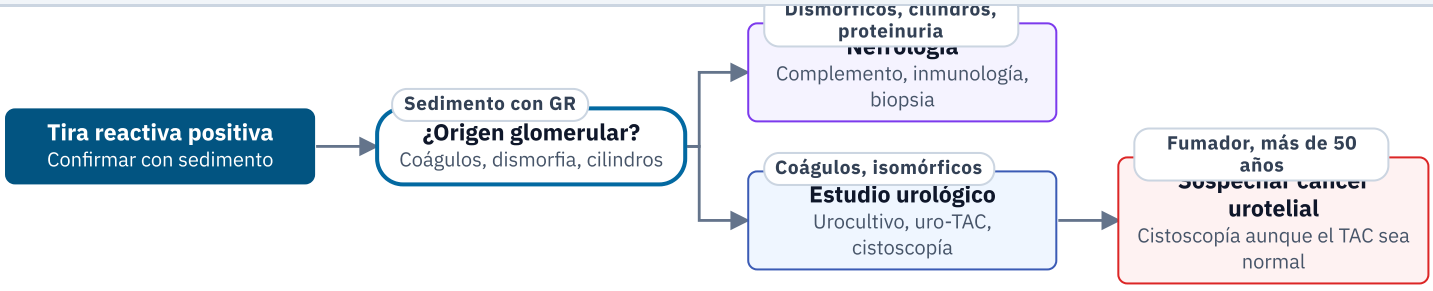


TABLA 13.15 · DIFERENCIACIÓN DIAGNÓSTICA: HEMATURIA GLOMERULAR VS HEMATURIA UROLÓGICA

PARÁMETRO DIFERENCIAL	HEMATURIA GLOMERULAR (NEFROLÓGICA)	HEMATURIA UROLÓGICA (QUIRÚRGICA)
Color de la Orina	Marrón oscuro, 'té cargado', color 'coca-cola'	Roja rutilante, rosada o 'agua de carne'
Presencia de Coágulos	AUSENTES SIEMPRE (la uroquinasa los lisa)	PRESENTES FRECUENTEMENTE (descarta glomerular)
Morfología Eritrocitaria	Hematíes Dismórficos (> 80%) y Acantocitos (> 5%)	Hematíes Isomórficos (> 80% normales bicóncavos)
Cilindros en Sedimento	Cilindros hemáticos patognomónicos o granulosos	Sin cilindros eritrocitarios (pueden haber leucocitos)
Proteinuria Concomitante	Frecuentemente significativa (> 500 mg - 3 g/d)	Ausente o mínima (< 300 mg/día)
Etiologías Frecuentes	Nefropatía por IgA, GN Postestreptocócica, Lupus	Litiasis urológica, Cáncer vesical, Cáncer renal, HPB
Estudio Inicial Obligatorio	Perfil inmunológico, C3/C4, biopsia renal (Nefrología)	Ecografía / Uro-TAC + Cistoscopía (Urología)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Tira positiva	Confirmar con sedimento	Diagnosticar hematuria
Dismórficos, cilindros hemáticos	Nefrología	Pedir cistoscopía
Isomórfica, fumador mayor de 50	Uro-TAC y cistoscopía	Controlar en un año

REGLA DE ORO **Confirmar con sedimento** — La tira puede engañar

PRACTICA **Libro Gordo Urología**, preguntas **86–90** (págs. 20–21) · solucionario pág. 35.

Clase 13.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 16 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · UROLITIASIS & OBSTRUCCIÓN URINARIA	
13.1 Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea	pág. 3
Ketorolaco **30 mg** EV — O ketoprofeno **100 mg** EV	DOSIS
Sensibilidad de **50 a 60 %** — No reemplaza al TAC	CORTE
TAC sin contraste — Sensibilidad y especificidad sobre **98%**	CORTE
Tamaño decide la conducta — Más de **10 mm**: LEOC o ureteroscopía	CORTE
13.2 Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía	pág. 4
Más de **1.000 mL** al sondar — Se observa al paciente	DOSIS
Calibre 16 a 18 French — Con lidocaína jalea al **2%**	CORTE
Lidocaína al **2 %**, línea media — **2 a 3 cm** sobre la sínfisis del pubis	CORTE
13.3 Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP	pág. 5
Qmax menor de 10: obstrucción — Mayor de **15 mL**/s es normal	DOSIS
Finasteride **5 mg**, dutasteride — Bajan la dihidrotestosterona	DOSIS
Residuo mayor de **100 mL** — Trabéculas, divertículos, hidronefrosis	DOSIS
13.4 Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica	pág. 7
Mirabegrón **50 mg** al día — Beta 3: mejor en ancianos	DOSIS
Residuo mayor de **200 mL** — Confirma falla de vaciamiento	DOSIS
Oxibutinina o tolterodina — Oxibutinina **5 mg** cada **8 a 12 h**	DOSIS
Cinta suburetral TOT o TVT — Éxito sobre **85%**	CORTE
BLOQUE 02 · URGENCIAS UROLÓGICAS & ESCROTO AGUDO	
13.5 Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h	pág. 8
Reflejo cremastérico abolido — Sensibilidad mayor de **95%**	CORTE
Todo testículo agudo se explora — Menos de **6 horas**: más de **90%**	TIEMPO
13.6 Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo	pág. 10
Ceftriaxona **500 mg** IM, una dosis — Cubre el gonococo	DOSIS
Doxiciclina **100 mg** cada **12 h** — Cubre Chlamydia, **10 a 14 días**	DOSIS
Tratar a la pareja — Últimos **60 días**; VIH y VDRL	TIEMPO
13.7 Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes	pág. 11
Orquidopexia entre 6 y **12 meses** — A más tardar a los **18 meses**	TIEMPO
Afecta al **1 a 3%** de los recién nacidos — Hasta **30%** de los prematuros	CORTE
El varicocele es la dilatación del plexo pampiniforme ('bolsa de gusanos') y el **90%** es del lado izquierdo.	CORTE
13.16 Patología Peneana: Fimosis, Parafimosis, Balanopostitis, Priapismo & Disfunción Eréctil	pág. 12
Sin respuesta en **4 a 6 semanas** — Biopsia	TIEMPO
Fenilefrina intracavernosa — **200 µg** cada **3 a 5 min**, máx. **1 mg**/h	DOSIS
Anticipa la enfermedad coronaria — En **2 a 5 años**	CORTE
Candida: clotrimazol **7 a 14 días** — Fluconazol **150 mg** si es extensa	DOSIS
BLOQUE 03 · URO-ONCOLOGÍA	
13.8 Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason	pág. 14
Biopsia en **30 días** — Desde la sospecha fundada	TIEMPO
Edad avanzada — Excepcional antes de los **45 años**	CORTE
GES: biopsia **30 días** — Tratamiento a los **60 días**	TIEMPO

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
13.9 Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia)	pág. 15
Disfunción eréctil progresiva — A los 2 o **3 años**	CORTE
Disfunción eréctil — **30 a 80%**, bandeletas de Walsh	CORTE
Incontinencia de esfuerzo — **5 a 15%**, esfínter estriado	CORTE
13.10 Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical	pág. 16
Seminoma — **50 a 55%**	CORTE
Criptorquidia — Riesgo **4 a 10 veces** mayor	CORTE
13.11 Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía	pág. 17
Células claras: **~80%** — Del túbulo proximal	CORTE
Varón de **50 a 70 años** — Tabaco, obesidad, hipertensión	CORTE
Incidentaloma: más del **65%** — Hallazgo en ecografía o TAC	CORTE
Papilar **10-15%**, cromófobo **5%** — Cromófobo: mejor pronóstico	CORTE
13.12 Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV	pág. 18
BCG intravesical — Inducción semanal por **6 semanas**	TIEMPO
Tabaquismo: factor principal — Riesgo **3 a 4 veces** mayor	CORTE
Frecuencia al diagnóstico · Aproximadamente el **75%** · Aproximadamente el **25%**	CORTE
BLOQUE 04 · INFECCIONES UROLÓGICAS, QUISTES & HEMATURIA	
13.13 Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia	pág. 19
Ambulatorio: ciprofloxacino — **500 mg** cada **12 h** por vía oral	DOSIS
E. coli en **75 a 80%** — Klebsiella, Proteus, Pseudomonas	CORTE
13.14 Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante	pág. 20
Quistes hepáticos — Más del **70%** de los casos	CORTE
Aneurisma de Berry — **8-10%**; **20%** con historia familiar	CORTE
13.15 Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas	pág. 21
Microscópica: **≥ 3 GR** por campo — En 2 de 3 sedimentos, a **400x**	CORTE
Acantocitos (> **5%**), hematíes dismórficos (> **80%**) y cilindros hemáticos certifican origen glomerular.	CORTE
Proteinuria Concomitante · Frecuentemente significativa (> **500 mg** - **3 g**/d) · Ausente o mínima (< **300 mg**/día)	DOSIS

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE	
13.1 Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea			pág. 3
AINE primero, opioide de rescate · Primera línea	**Ketorolaco 30 mg EV**	O ketoprofeno **100 mg** EV	
Evitar que vuelva · Según la causa	**Hipercalciuria: hidroclorotiazida**	Estimula la reabsorción de calcio	
13.6 Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo			pág. 10
Antibiótico según la edad · Menor de 35 años	**Ceftriaxona 500 mg IM, una dosis**	Cubre el gonococo	
Antibiótico según la edad · Menor de 35 años	**Doxiciclina 100 mg cada 12 h**	Cubre Chlamydia, **10 a 14 días**	
Antibiótico según la edad · Mayor de 35 años	**Ciprofloxacino 500 mg cada 12 h**	O levofloxacino **500 mg** al día	
Uretritis · Diagnóstico y conducta	**Ceftriaxona más azitromicina**	**500 mg** IM más **1 g** oral, dosis única	
13.16 Patología Peneana: Fimosis, Parafimosis, Balanopostitis, Priapismo & Disfunción Eréctil			pág. 12
Lo haces tú	**Candida: clotrimazol 7 a 14 días**	Fluconazol **150 mg** si es extensa	
Lo haces tú · Niño: baños de asiento	**Antibiótico oral si hay celulitis**		
13.10 Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical			pág. 16
Después de la orquiectomía · Terapia según tipo	**Antes de quimioterapia**		
13.11 Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía			pág. 17
Cirugía · Enfermedad avanzada	**Sunitinib, nivolumab**		
13.13 Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia			pág. 19
Antibiótico que penetre, y largo · Cómo se indican	**Ambulatorio: ciprofloxacino**	**500 mg** cada **12 h** por vía oral	
Antibiótico que penetre, y largo · Cómo se indican	**Ceftriaxona EV ± gentamicina**		
13.14 Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante			pág. 20
Complicaciones fuera del riñón · Base	**Cefalea atípica o familiar**		
13.15 Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas			pág. 21
Síndrome nefrítico · Manejo inicial	**Furosemida si hay sobrecarga**		

GES de Urología

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

GES GES N° 10: Tratamiento Quirúrgico de la Hiperplasia Benigna de la Próstata en personas sintomáticas

Tema **13.3** · Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP
`4.03.1.013` · `4.03.1.027` · `4.03.3.002`
pág. **5**

GES GES N° 19: Cáncer de Próstata en personas de 15 años y más

Tema **13.8** · Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason
`4.03.1.002` · `4.03.3.005` · `4.03.4.010`
pág. **14**

Fármacos de primera línea · continuación

GES GES N° 19: Garantía de Tratamiento y Seguimiento en Cáncer de Próstata

Tema **13.9** · Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia)
`4.03.1.002`
pág. **15**

GES GES N° 20: Cáncer de Testículo en personas de 15 años y más

Tema **13.10** · Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical
`4.03.1.024` · `4.03.4.008` · `4.03.3.003`
pág. **16**

GES GES N° 76: Cáncer Renal en personas de 15 años y más

Tema **13.11** · Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía
`4.03.1.022` · `4.03.4.004` · `2.01.1.037`
pág. **17**

GES GES N° 69: Cáncer Vesical en personas de 15 años y más

Tema **13.12** · Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV
`4.03.1.003` · `4.03.5.002` · `4.03.1.010`
pág. **18**

Sin garantía GES específica (10 temas): 13.1 · 13.2 · 13.4 · 13.5 · 13.6 · 13.7 · 13.16 · 13.13 · 13.14 · 13.15. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

3 temas · ★★★

- ★★★ **13.1** Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea 3
- ★★★ **13.16** Patología Peneana: Fimosis, Parafimosis, Balanopostitis, Priapismo & Disfunción Eréctil 12
- ★★★ **13.4** Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica 7

Practica: Libro Gordo Urología, preguntas 1–11, 21–25, 37.

DÍA 2

3 temas · ★★★

- ★★★ **13.15** Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas 21
- ★★★ **13.11** Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía 17
- ★★★ **13.5** Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h 8

Practica: Libro Gordo Urología, preguntas 26–31, 64–66, 86–90.

DÍA 3

3 temas · ★★

- ★★☆ **13.2** Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía 4
- ★★☆ **13.7** Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes 11
- ★★☆ **13.8** Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason 14

Practica: Libro Gordo Urología, preguntas 12–17, 20, 38, 40–51, 57–59, 73.

DÍA 4

3 temas · ★★

- ★★☆ **13.12** Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV 18
- ★★☆ **13.3** Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP 5
- ★★☆ **13.6** Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo 10

Practica: Libro Gordo Urología, preguntas 18, 32–36, 55, 67–72.

DÍA 5

2 temas · ★★

- ★★☆ **13.9** Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia) 15
- ★☆☆ **13.10** Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical 16

Practica: Libro Gordo Urología, preguntas 19, 52–54, 60–63.

DÍA 6

2 temas · ★

- ★☆☆ **13.13** Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia 19
- ★☆☆ **13.14** Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante 20

Practica: Libro Gordo Urología, preguntas 75–85.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 22
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 13.1 · 13.4 · 13.5 · 13.16 · 13.11 · 13.15
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Urología en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 6 temas

19 13.1. Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea 3
11 13.16. Patología Peneana: Fimosis, Parafimosis, Balanopostitis, Priapismo & Disfunción Eréctil 12
10 13.4. Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica 7
8 13.15. Estudio Sistemático de la Hematuria: Glomerular vs Urológica & Banderas Rojas 21
7 13.11. Cáncer Renal: Carcinoma de Células Claras, Tríada Clásica, TAC y Nefrectomía GES 17
6 13.5. Torsión Testicular vs Torsión de Hidátide: Doppler Testicular & Exploración Quirúrgica <6h 8

★★ Prioridad media · 7 temas

5 13.2. Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía 4
5 13.7. Patología Escrotal No Dolorosa: Varicocele, Hidrocele, Espermatocele & Quistes 11
5 13.8. Cáncer de Próstata: Tamizaje APE, Tacto Rectal, Biopsia y Score de Gleason GES 14
4 13.12. Cáncer de Vejiga: Hematuria Macroscópica Silente, Cistoscopía & RTUV GES 18
3 13.3. Hiperplasia Prostática Benigna (HPB): IPSS, Tacto Rectal, Tamsulosina/Finasteride & RTUP GES 5
3 13.6. Orquiepididimitis Aguda: Etiología según Edad (<35 años ETS vs >35 años E. coli) & Manejo 10
3 13.9. Cáncer de Próstata: Tratamiento según Riesgo (Cirugía, Radioterapia, Hormonoterapia) GES 15

★ Prioridad baja · 3 temas

2 13.10. Cáncer de Testículo: Masas Indoloras, Marcadores (AFP, b-hCG, LDH) & Orquiectomía Radical GES 16
2 13.13. Prostatitis Aguda y Crónica: Peligro de Sepsis, Antibióticos Prolongados & Prostatodinia 19
0 13.14. Quistes Renales Simples (Bosniak) & Riñón Poliquístico Autosómico Dominante 20